

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Gonorrea, Clamidia, VIH, Sífilis, VPH y Herpes

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones de transmisión sexual (ITS)** constituyen un **problema de salud pública relevante en Chile y el mundo**, con impacto en morbilidad reproductiva, embarazo, riesgo de transmisión vertical y coinfección por VIH.

El **MINSAL (Norma Técnica de Manejo Sindrómico de ITS, 2022)** define las ITS como infecciones que se **transmiten principalmente por contacto sexual**, incluyendo relaciones vaginales, anales u orales.

En Chile, las ITS más prevalentes son:

- *Chlamydia trachomatis*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Virus Herpes Simple (VHS-2)
- Sífilis (*Treponema pallidum*)
- VIH

□ En el EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en:

- Diagnóstico y manejo antibiótico de gonorrea y clamidia.
- Interpretación de serología en sífilis.
- Tamizaje y prevención de VIH y VPH.
- Conducta frente a úlceras genitales o flujo purulento.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las ITS afectan principalmente el **tracto genital inferior (uretra, cuello uterino, vagina)** y pueden ascender a estructuras pélvicas (EIP). También pueden producir manifestaciones **extragenitales o sistémicas** (cutáneas, neurológicas, hepáticas).

El daño es causado por:

- **Infección directa** del epitelio mucoso.
 - **Inflamación local** con daño tisular.
 - **Diseminación hematógena** en algunos casos (sífilis, VIH).
 - **Inmunosupresión asociada** o coinfecciones.
-

3. Epidemiología en Chile

Según MINSAL:

- Mayor incidencia en **jóvenes de 15–29 años**.
 - **Clamidia**: ITS bacteriana más frecuente en mujeres jóvenes.
 - **Gonorrea**: reemergente con resistencia a antibióticos.
 - **Sífilis y VIH**: aumento sostenido en última década.
 - **VPH**: prevalencia alta, relacionado con cáncer cervicouterino.
 - **Herpes genital**: frecuente y recidivante, sin cura definitiva.
-

4. Principales ITS bacterianas

A.

Gonorrea (*Neisseria gonorrhoeae*)

a. Fisiopatología

Diplococo Gram negativo intracelular. Infecta mucosa endocervical, uretral y rectal.

b. Clínica

- **Mujeres:** flujo purulento, disuria, dolor pélvico, sangrado postcoital.
- **Hombres:** uretritis purulenta con ardor al orinar.
- Puede causar EIP o conjuntivitis neonatal.

c. Diagnóstico

- Tinción de Gram: diplococos Gram negativos intracelulares.
- PCR o cultivo en Thayer-Martin (gold standard).

d. Tratamiento (MINSAL 2023)

- **Ceftriaxona 500 mg IM dosis única**
 - **Azitromicina 1 g VO dosis única** (cubre coinfección por clamidia).

e. Complicaciones

EIP, infertilidad, diseminación gonocócica (artritis séptica, dermatitis).

B.

Clamidia (*Chlamydia trachomatis*)

a. Fisiopatología

Bacteria intracelular obligada (serotipos D–K). Transmisión sexual y vertical.

b. Clínica

- **Mujeres:** cervicitis mucopurulenta, disuria leve, flujo escaso, sangrado postcoital.
- **Hombres:** uretritis no gonocócica, epididimitis.
- Alta proporción asintomática (>50%).

c. Diagnóstico

- PCR en muestra endocervical o de orina.

d. Tratamiento

- **Doxiciclina 100 mg VO cada 12 h × 7 días**
o **Azitromicina 1 g VO dosis única.**

e. Complicaciones

EIP, infertilidad, embarazo ectópico, conjuntivitis o neumonía neonatal.

f. Tamizaje (MINSAL)

- Mujeres <25 años sexualmente activas.
 - Embarazadas en primer control prenatal.
-

C.

Sífilis (*Treponema pallidum*)

a. Etapas clínicas

Fase	Clínica característica
Primaria	Chancro indoloro, base limpia, adenopatía regional.
Secundaria	Exantema maculopapular (palmas y plantas), condilomas planos, fiebre.
Latente	Asintomática, serología reactiva.
Terciaria	Gomas, neurosífilis, afectación cardiovascular.

b. Diagnóstico serológico

1. **Prueba no treponémica:** VDRL o RPR → títulos cuantitativos.
2. **Prueba treponémica:** FTA-ABS o TPHA → confirma infección.

□ En EUNACOM:

“VDRL reactivo, FTA-ABS positivo” = sífilis activa o pasada (confirmar con título).

c. Tratamiento (según etapa)

- **Primaria / Secundaria / Latente temprana:**

Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única.

- **Latente tardía / Desconocida:**

Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM semanal × 3 semanas.

- **Neurosífilis:**

Penicilina G sódica 3–4 millones UI IV cada 4 h × 14 días.

d. Control

- Repetir VDRL a los 3, 6 y 12 meses.
- Caída ≥ 4 veces del título = respuesta adecuada.

e. Embarazo

- Misma dosis; tratar **siempre con penicilina**.
- Alergia → desensibilización (ninguna alternativa eficaz).
- **Tamizaje obligatorio** en 1.er control, 28 semanas y parto.

5. Principales ITS virales

A.

VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)

a. Transmisión

Sexual, sanguínea y vertical.

Aumenta riesgo con ITS ulcerativas.

b. Diagnóstico

- **Test rápido o ELISA de 4.^a generación** → anticuerpos + antígeno p24.
- Confirmación con **Western Blot o PCR**.

c. Tamizaje en Chile

- **Oferta universal** en controles de embarazo, ingreso hospitalario, ITS y parejas.
- Aprobación verbal suficiente.

d. Tratamiento

- **Terapia antirretroviral combinada (TARV)** inmediata al diagnóstico.
- Control en programa nacional de VIH (MINSAL).

e. Prevención

- Preservativo.
 - **Profilaxis postexposición (PEP)**: dentro de 72 h.
 - **Profilaxis preexposición (PrEP)**: grupos de riesgo (HSH, parejas serodiscordantes).
-

B.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

a. Tipos

- **Bajo riesgo**: 6 y 11 (condilomas).
- **Alto riesgo**: 16, 18, 31, 33, 45 (cáncer cervicouterino).

b. Clínica

- Condilomas acuminados (verrugas genitales).
- Lesiones intraepiteliales (detectadas por PAP o test VPH).

c. Diagnóstico

- Papanicolaou (citología cervical).
- Test de VPH (detección de ADN viral).
- Colposcopia si citología anormal.

d. Tratamiento

- **Condilomas:** ácido tricloroacético, crioterapia o imiquimod tópico.
- **Lesiones intraepiteliales:** manejo según protocolo de colposcopia (ver Tema 22).

e. Prevención

- **Vacuna VPH:**
 - Niñas y niños de **9 a 14 años (2 dosis)**.
 - **Mujeres hasta 45 años** pueden beneficiarse.
 - Uso de preservativo reduce transmisión, pero no la elimina.
-

C.

Herpes genital (Virus Herpes Simple tipo 2 y 1)

a. Clínica

- Vesículas dolorosas → úlceras múltiples.
- Disuria, fiebre, linfadenopatía inguinal.
- Primer episodio más severo; recurrencias frecuentes.

b. Diagnóstico

- Clínico + PCR o cultivo viral si disponible.

c. Tratamiento

- **Aciclovir 400 mg VO cada 8 h × 7–10 días** (primoinfección).
- **Recurrencias:** 400 mg VO cada 8 h × 5 días.
- Supresivo si >6 episodios/año: 400 mg VO c/12 h continuo.

d. Embarazo

- Profilaxis desde semana 36 con aciclovir si antecedentes de herpes.
- Cesárea si lesiones activas al parto.

6. Tamizaje y manejo sindrómico (según MINSAL)

a. Síndrome de flujo vaginal

→ Metronidazol + tratamiento específico según agente (ver temas previos).

b. Síndrome de úlcera genital

→ Penicilina benzatina (sífilis) + Aciclovir (herpes).

c. Síndrome de descarga uretral

→ Ceftriaxona + Doxiciclina.

d. Tamizaje general

- Mujeres <25 años: clamidia y gonorrea.
- Embarazo: VIH y sífilis obligatorios.
- Papanicolaou cada 3 años (25–64 años).
- Test VPH desde los 30 años.

7. Complicaciones generales de las ITS

Complicación	Infección asociada
EIP, infertilidad, embarazo ectópico	Clamidia, gonorrea
Ceguera neonatal, neumonía	Clamidia
Aborto, parto prematuro, sífilis congénita	Sífilis
Cáncer cervicouterino	VPH 16 y 18
Herpes neonatal diseminado	VHS-2
Coinfección VIH	Cualquier ITS ulcerativa

8. Prevención integral

1. **Educación sexual y uso consistente de preservativo.**
 2. **Vacunación VPH** (niñas y niños desde 9 años).
 3. **Tamizaje rutinario** en población sexualmente activa.
 4. **Notificación y tratamiento de parejas sexuales.**
 5. **Profilaxis postexposición (VIH).**
 6. **Consejería en salud sexual sin discriminación ni estigmas.**
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Gonorrea y clamidia: flujo purulento → **Ceftriaxona + Azitromicina**.
2. Sífilis primaria: chancro indoloro → **Penicilina benzatina**.
3. Tricomoniasis: flujo espumoso verdoso → **Metronidazol DU**.
4. Herpes: vesículas dolorosas → **Aciclovir**.
5. VPH: condilomas → **Crioterapia o imiquimod; vacuna preventiva**.
6. VIH: test rápido universal + TARV inmediato.
7. Siempre tratar **pareja sexual** y reforzar **preservativo**.



Errores comunes

- No tratar coinfección gonorrea/clamidia simultáneamente.
- Indicar antibióticos orales ineficaces (ej. amoxicilina en gonorrea).
- No tamizar VIH o sífilis en embarazo.
- No tratar pareja sexual en ITS curables.
- Confundir chancro duro (sífilis) con herpes genital (doloroso).

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las ITS más comunes en Chile son **clamidia, gonorrea, VPH, sífilis, VIH y herpes**.
2. **Tratamiento estándar de gonorrea/clamidia:** Ceftriaxona + Azitromicina.
3. **Sífilis:** Penicilina benzatina; tamizaje obligatorio en embarazo.
4. **VIH:** diagnóstico con test rápido, TARV inmediato.
5. **VPH:** vacuna y PAP/Test VPH para tamizaje de cáncer cervicouterino.

6. **Herpes genital:** tratamiento sintomático con aciclovir.
7. Toda atención debe incluir **educación, consejería y tratamiento de pareja.**